

【编者按】随着我国老龄人口的增加、生活方式的改变,成人糖尿病患病率显著增高,已成为严重的公共卫生问题。本期糖尿病护理专题围绕糖尿病患者的血糖监测规范、共病患者围手术期的血糖护理、妊娠期糖尿病孕妇的饮食管理、糖尿病足溃疡患者的运动等护理难点组织了5篇文章。《住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识》针对血糖监测的关键问题,结合文献、医疗和护理专家的临床经验,制订了医护协议处方共识,建议护士可按照共识中的方案与流程监测血糖,保证血糖管理的同质化、规范化;《甲状腺癌合并糖尿病患者术前口服5%葡萄糖溶液的可行性研究》提出甲状腺癌合并糖尿病患者术前口服5%葡萄糖不增加患者的术后血糖,且能减轻患者口渴感,降低患者咽喉部疼痛和术后应激等不良反应;《妊娠期糖尿病孕妇饮食行为改变特征及原因的质性研究》发现妊娠期糖尿病孕妇存在高危妊娠压力感,被迫消极进行饮食管理,并存在家庭支持不足、工作时间和场所限制等阻碍孕妇饮食管理的因素;《糖尿病足溃疡患者非负重运动的研究进展》建议以靶心率作为判定非负重运动强度的指标,遵循从小到大、循序渐进的运动原则,个性化地调整运动时间,并使用综合指标评价非负重运动的效果;《回族老年2型糖尿病患者主要照顾者照顾感受的质性研究》分析了回族文化和饮食偏好对老年2型糖尿病患者主要照顾者照顾感受和照顾行为的影响,并提出相应的解决方法。敬请关注。

住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识



中华护理学会糖尿病护理专业委员会(执笔:莫永珍 赵芳 袁丽 邢秋玲 张明霞 赵春艳)

【摘要】 **目的** 制订住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识。**方法** 针对住院成人高血糖患者血糖监测的关键问题,通过查阅国内外相关文献,结合医疗专家及护理专家的临床经验,设计专家函询表。采用2轮德尔菲专家函询法结合专家共识会议法对各个条目进行修改、完善。**结果** 住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识包括血糖监测处方、血糖控制目标、血糖监测的健康教育、血糖监测的质量控制4个方面。**结论** 住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识具有较强的可靠性和实用性,有助于指导临床制订系统规范的血糖监测方案,提升临床管理质量,为我国护士开具血糖监测处方奠定了坚实的基础。

【关键词】 高血糖; 血糖监测; 处方; 专家共识, 护理

Consensus on medical protocol prescription for blood glucose monitoring in adult inpatients with hyperglycemia/Diabetes Nursing Committee of Chinese Nursing Association (Writing Committee: MO Yongzhen, ZHAO Fang, YUAN Li, XING Qiuling, ZHANG Mingxia, ZHAO Chunyan)

【Abstract】 **Objective** To establish expert consensus on medical protocol prescription for blood glucose monitoring in hospitalized adult patients with hyperglycemia. **Methods** Targeting key issues in blood glucose monitoring among hospitalized adult patients with hyperglycemia, literatures at home and abroad were retrieved, and clinical experience of medical and nursing experts were taken into consideration, to design expert questionnaire. Each item was revised and improved through two rounds of Delphi expert consultation and expert meeting. **Results** Consensus on medical protocol prescription included four aspects: prescription for blood glucose monitoring, glycemic control goals, health education for blood glucose monitoring, and quality control for blood glucose monitoring. **Conclusion** The consensus has strong reliability and practicability, which is helpful to guide development of clinical systematic and standardized monitoring program, improve quality of clinical management, lay a solid foundation for the development of nurses' prescription in China.

【Key words】 Hyperglycemia; Blood Glucose Monitoring; Prescript; Expert Consensus, Nursing Care



本文作者:莫永珍

据国际糖尿病联盟^[1]统计,2017年中国约有1.14亿例糖尿病患者。美国糖尿病学会指南(2018年版)^[2]认为,住院患者任意时间点的血糖值>7.8 mmol/L,即可判定为院内高血糖,当患者血糖值

DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2019.08.004

作者单位:210024 南京市 南京医科大学附属老年医院护理部(莫永珍);中日友好医院护理部(赵芳);四川大学华西医院大内科(袁丽);天津医科大学朱宪彝纪念医院护理部(邢秋玲);北京大学人民医院内分泌科(张明霞);上海东方医院大内科(赵春艳)

通信作者:赵芳, E-mail: zhaof01@aliyun.com

莫永珍:女,硕士,主任护师,护理部主任, E-mail: moyongzh@sina.com

2019-01-24收稿



持续 >7.8 mmol/L时需要接受治疗。持续高血糖状态会对住院患者的心、脑、血管及其他器官造成危害,对疾病预后产生不利影响,增加手术风险及院内并发症发生风险,导致患者住院时间延长、医疗花费增加、再次入院率增高^[3]。国内外指南和共识^[4-7]提出,需要加强院内血糖控制,合理监测患者血糖,改善患者预后。研究^[8-9]表明,国内住院患者血糖监测问题较多,包括血糖监测不规范,转换科室、多科室协调管理、会诊时打破血糖监测的连续性,血糖管理及培训考核制度不完善等。现今,已有22个国家的护士拥有一定范围内的处方权,且在逐年增加^[10]。而我国护士处方权尚处于起步阶段^[11],专家对护士开具健康教育、针管式注射器、血糖和尿糖监测处方的认同度较高^[12]。目前糖尿病治疗程序明确,由护士以独立处方或者协议处方的形式开具检查项目和常用器械可减少医生的工作量^[12],便于患者进一步治疗。为加强院内血糖监测与护理的同质化、规范化管理,中华护理学会糖尿病专业委员会联合内分泌科医疗专家,结合我国实际,依据最新的循证医学证据,在2017年《高血糖患者围手术期血糖护理工作指引》^[13]的基础上,制订了《住院成人高血糖患者血糖监测医护协议处方共识》(以下简称《处方共识》),在医生与护士共同协议的前提下,制订系统的监测方案与流程,避免盲目无序的血糖监测,以提升临床血糖管理质量,提高患者满意度。

1 《处方共识》的形成方法

1.1 成立《处方共识》专家组

研究小组成员共2名,负责查阅国内外文献,进行专家访谈,编制专家函询表,汇总和分析函询结果。函询专家组共12名专家,包括主任护师3名,副主任护师5名,主管护师3名,糖尿病教育专家1名。意见征求专家组共6名专家,主要负责评定条目的学术性及临床可操作性,包括内分泌科主任医师4名,主任护师1名,编审1名。

1.2 制订函询问卷

在回顾文献及专家访谈的基础上,自行设计《处方共识》专家函询表,包括函询说明书和函询正文。函询说明书解释了本研究的目的、意义及步骤;函询正文要求专家对各条目的重要性及可实施性进行评价,并提出相应建议。

1.3 函询方法

采用电子邮件发放函询问卷,要求专家7 d内返回。专家对函询问卷中列出的条目进行删除、修正或添加个人建议。第1轮函询未达成共识或存在争议的条目,结合专家意见进入第2轮函询,并在专家共识会议中再次讨论。

2 《处方共识》内容

专家组参考现有文献并结合经验,就推荐意见达成共识。A类:已被证实或公认有效,可以直接指导实践(证据来源于Meta分析、大样本的随机对照研究);B类:证据或观点倾向于有用和有效,大多数情况下可以指导实践(证据来源于小样本的随机对照研究);C类:证据或观点有支持,但应注意其应用的局限性(证据来源于非随机对照研究,如回顾性研究、横断面研究);D类:证据薄弱,仅为专家共识。

2.1 血糖监测处方

2.1.1 一般高血糖人群血糖监测处方

根据饮食和用药情况,将一般高血糖人群分为I、II、III、IV 4类,推荐采取不同的血糖监测处方^[2,14-16],见表1。

2.1.2 1型糖尿病患者血糖监测处方

非正常进食且静脉注射胰岛素的患者,血糖应每小时监测1次;非正常进食且皮下注射胰岛素的患者,每4 h监测1次血糖;正常进食者维持院前血糖监测方案^[4]。

2.1.3 特殊人群血糖监测处方

特殊人群主要指围手术期、妊娠期、老年、ICU及急危重症患者,不同人群的血糖监测方案不同。特殊人群的血糖监测应遵循一般高血糖人群血糖监测的原则,根据药物治疗方案、血糖控制水平、个人需求和目标来实行个体化的监测方案^[4,5,13,17],见表2。

2.1.4 加测建议

表1 一般高血糖人群血糖监测处方

人群	饮食及用药情况	监测时间	建议等级
I类	正常进食、每日1~2次注射胰岛素或口服降糖药物	监测4次(三餐前、睡前)	D
II类	正常进食、每日多次注射胰岛素或使用胰岛素泵	监测7次(三餐前、三餐后2 h、睡前)	D
III类	肠内或肠外营养、口服降糖药物或皮下注射胰岛素(含使用胰岛素泵)	每4~6 h监测	D
IV类	静脉输注胰岛素(无论何种进食方式)	每1~2 h监测	D

表2 特殊人群血糖监测处方

人群	饮食及治疗方法	监测时间	建议等级
围手术期患者	正常进食	空腹、三餐后 2 h、睡前	D
	禁食	每 4~6 h 监测	D
	危重症、大手术或持续静脉输注胰岛素	每 1~2 h 监测	D
妊娠期患者	非胰岛素治疗	空腹、三餐后 1 h 与 2 h	B
	新诊断为高血糖,血糖控制不稳定,需胰岛素治疗	三餐前、三餐后 1 h 与 2 h、03:00	B
老年患者	-	参照一般人群,实行个体化的监测方案	A
ICU 患者	-	每 0.5~2 h 监测	D
急危重症患者	急性期	每 1 h 监测	D
	缓解期	每 4~6 h 监测	D

注:床旁快速监测指血糖适用于一般情况良好的患者,对于危重症、手术时间长、创伤大的术中患者应通过动脉血气分析监测即时血糖^[18]。

患者发生低血糖时,需及时纠正,并加强血糖监测,每 15 min 监测 1 次^[19],对于严重低血糖的昏迷患者,每 10 min 监测 1 次,直至低血糖被纠正^[20];对于出现不明原因的空腹高血糖或夜间低血糖的患者,应增加监测 02:00~03:00 的血糖^[15]。

2.1.5 出院后血糖监测处方

患者需根据自身情况定时监测血糖。通过改善生活方式控制高血糖的患者,可通过监测血糖了解饮食和运动对血糖的影响;使用口服降糖药控制高血糖的患者,每周监测 2~4 次空腹或餐后血糖,或者在就诊前 1 周连续监测 3 d,每天监测 7 次(三餐前、三餐后 2 h、睡前);使用胰岛素治疗的患者,可根据胰岛素治疗方案监测血糖^[5]。

2.2 血糖控制目标

2.2.1 成人非妊娠高血糖人群的血糖控制目标

成人非妊娠高血糖人群空腹或餐前血糖严格控制目标为 4.4~6.1 mmol/L,一般控制目标为 6.1~7.8 mmol/L,宽松控制目标为 7.8~10.0 mmol/L;餐后 2 h 或随机血糖严格控制目标为 6.1~7.8 mmol/L,一般控制目标为 7.8~10.0 mmol/L,宽松控制目标为 7.8~13.9 mmol/L。推荐等级为 A 级。成人非妊娠高血糖人群血糖控制内容见表 3。

2.2.2 妊娠高血糖人群的血糖控制目标

与非妊娠糖尿病患者相比,妊娠高血糖人群的血糖控制目标更为严格^[17]。孕期不推荐使用口服降

糖药,计划妊娠者停用除二甲双胍以外的口服降糖药,加用或改用胰岛素治疗,在不出现低血糖的前提下严格控制血糖^[19]。妊娠高血糖人群血糖控制目标见表 4^[4]。

2.3 血糖监测的健康教育

健康教育内容包括:①不同时间点血糖的定义及临床意义;②个体化的血糖目标设定值;③血糖监测频率;④高血糖的症状及处理;⑤低血糖的症状及处理;⑥血糖仪的维护;⑦血糖试纸的采购与保管;⑧不同血糖测定方法的意义,如毛细血管血糖、动态血糖监测等;⑨记录血糖日志;⑩遵循医生制订的用药方案,定期复诊。

2.4 血糖监测的质量控制

床旁快速血糖监测的优势在于监测时间短,样本量少。进行床旁快速血糖监测时,护士需掌握监测仪器的使用方法,了解常见影响血糖的因素。患者因素包括:糖尿病类型、年龄、病程、疾病状态、是否合并特殊疾病等;监测因素包括:环境温度、仪器设备种类、设备本身属性、仪器设备校正、试纸属性(有效期、保存条件、酶的特性)等;人员因素包括:监测技术水平等。护士应掌握患者红细胞压积、血压、末梢循环、血氧浓度的变化和特殊用药对床旁快速血糖监测结果的干扰。建议临床实际工作中制订相应的规章制度和质量管理标准,床旁血糖监测质量控制参考标准可扫文后二维码查看。

3 《处方共识》的应用说明和实施流程

《处方共识》结合国内外血糖监测指南及内分泌领域医护专家的建议形成。应用说明如下:①处方由医护团队事先达成协议,护士在处方授权的范围内直接实施;②推荐在跨学科血糖控制比较成熟的医疗机构使用;③处方的应用由内分泌科医生、糖尿病专科护士、护理管理者、内科或外科医生为主的全院血糖控制委员会审核和监管;④处方可以根据医院的具体情况作出调整;⑤注明制订和修订时间以及审核人。实施流程见图 1。具体示例可扫文后二维码查看。

表3 成人非妊娠高血糖人群血糖控制内容

饮食	用药	其他条件	血糖控制目标
正常进食	口服降糖药物或皮下注射胰岛素(含胰岛素泵治疗)	新诊断、非老年、无并发症及合并症,无低血糖风险(B级推荐)、精细手术(如整形)(D级推荐)	空腹或餐前血糖4.4~6.1 mmol/L;餐后2 h或随机血糖6.1~7.8 mmol/L
正常进食	口服降糖药物或皮下注射胰岛素(含胰岛素泵治疗)	择期手术(D级推荐)、器官移植手术(D级推荐)、心脑血管疾病高危人群 ¹⁾ (A级推荐)、稳定心脑血管疾病(B级推荐)、糖皮质激素治疗(D级推荐)	空腹或餐前血糖6.1~7.8 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~10.0 mmol/L
正常进食	静脉输注胰岛素	非ICU或外科ICU患者 ⁴⁾ (D级推荐)	空腹或餐前血糖6.1~7.8 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~10.0 mmol/L
肠内或肠外营养	口服降糖药物或每日1~2次皮下注射胰岛素	—	空腹或餐前血糖6.1~7.8 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~10.0 mmol/L
正常进食	口服降糖药物或皮下注射胰岛素(含胰岛素泵治疗)	低血糖高危人群 ²⁾ (B级推荐)、心脑血管疾病入院(B级推荐)、中重度肝肾功能不全(D级推荐)、≥75岁,预期寿命<5年,精神或智力障碍(D级推荐),急诊手术(D级推荐)	空腹或餐前血糖7.8~10.0 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~10.0 mmol/L
正常进食	静脉输注胰岛素	内科ICU ⁴⁾ (C级推荐)	空腹或餐前血糖7.8~10.0 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~13.9 mmol/L
肠内或肠外营养	口服降糖药物或每日1~2次皮下注射胰岛素	低血糖高危人群、因心脑血管疾病入院、中重度肝肾功能不全、年龄≥75岁、预期寿命<5年、精神或智力障碍、急诊手术(D级推荐)	空腹或餐前血糖7.8~10.0 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~13.9 mmol/L
肠内或肠外营养	每日多次皮下注射胰岛素或静脉输注胰岛素(D级推荐)	—	空腹或餐前血糖7.8~10.0 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~13.9 mmol/L
肠内或肠外营养	无论何种治疗	ICU ⁴⁾ (D级推荐)	空腹或餐前血糖7.8~10.0 mmol/L;餐后2 h或随机血糖7.8~13.9 mmol/L

注:1)心脑血管疾病高危人群为年龄>50岁的男性或年龄>60岁的女性合并1项危险因素者(心血管疾病家族史、高血压、吸烟、血脂紊乱或蛋白尿)^[2,4];2)低血糖高危人群为糖尿病病程>15年、存在无感知性低血糖病史和严重合并症(肝肾功能不全、全天血糖波动大并反复出现低血糖)的患者^[2,4]。

参与制订的专家(按姓氏汉语拼音排序):董颖越(中国医学科学院北京协和医院内分泌科)、李君(北京大学第一医院内分泌科)、李阳溪(中日友好医院内分泌科)、莫永珍(南京医科大学附属老年医院护理部)、王美君(天津医科大学朱宪彝纪念医院内分泌科)、王群(北京大学第三医院内分泌科)、邢秋

玲(天津医科大学朱宪彝纪念医院护理部)、袁丽(四川大学华西医院大内科)、张明霞(北京大学人民医院内分泌科)、张玉红(稳捷糖尿病学院)、赵春艳(上海东方医院大内科)、赵芳(中日友好医院护理部)

参与征求意见的专家(按姓氏汉语拼音排序):郭晓蕙(北京大学第一医院内分泌科)、李光伟(中国医学科学院阜外医院内分泌和心血管病诊治中心)、陆菊明(解放军总医院内分泌科)、唐伟(南京医科大学附属老年医院内分泌科)、巫海娣(南京医科大学附属老年医院内分泌科)

参考文献

- [1] IDF. IDF Diabetes Atlas[EB/OL]. [2019-01-24]. https://diabetesatlas.org/IDF_Diabetes_Atlas_8e_interactive_EN/.
- [2] American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2018[J]. Diabetes Care, 2018, 41(1): 1-159.

表4 妊娠高血糖人群血糖控制目标

人群	血糖控制目标	建议等级
计划妊娠	餐前血糖 3.9~6.5 mmol/L, 餐后血糖<8.5 mmol/L	B
妊娠	餐前、夜间及空腹血糖 3.3~5.6 mmol/L, 餐后峰值血糖 5.6~7.1 mmol/L	D
妊娠糖尿病	空腹血糖≤5.3 mmol/L, 餐后 1 h≤7.8 mmol/L, 餐后 2 h≤6.7 mmol/L	B

所有患者入院时,即刻监测血糖,若血糖 >7.8 mmol/L,需加测糖化血红蛋白来明确是否为糖尿病;对已经确诊为糖尿病的患者,无论血糖是否 >7.8 mmol/L都纳入管理流程

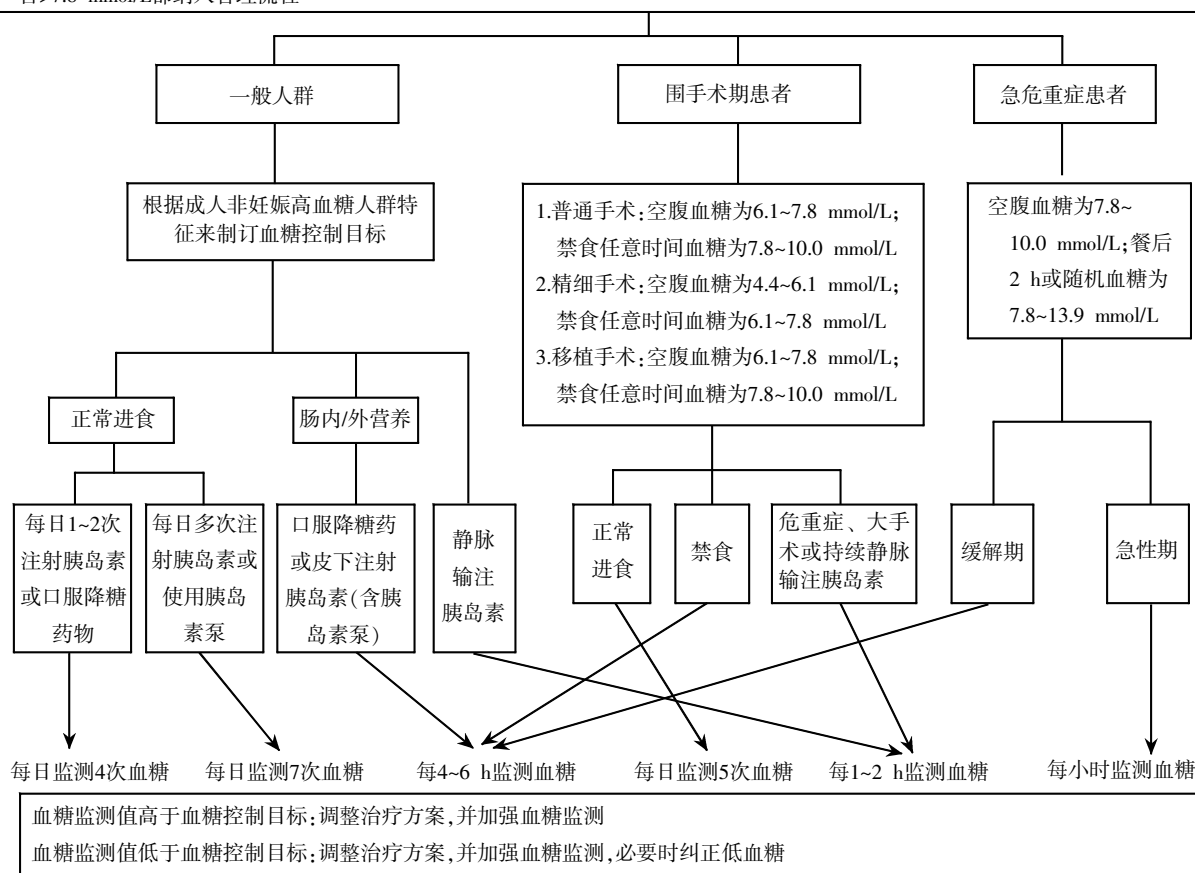


图1 住院高血糖患者血糖监测处方实施流程



床旁血糖监测质量控制
参考标准及《处方共识》
实施流程示例二维码

- [3] 孙衍,王彦,夏新霞,等.对住院患者院内高血糖的临床观察[J].医学信息,2015,28(19):31-32.
- [4] 中国医师协会内分泌代谢科医师分会.中国住院患者血糖管理专家共识[J].中华内分泌代谢杂志,2017,33(1):1-10.
- [5] 中华医学会糖尿病学分会.中国血糖监测临床应用指南(2015年版)[J].中华糖尿病杂志,2015,7(10):603-613.
- [6] 中华医学会糖尿病学分会.中国持续葡萄糖监测临床应用指南(2017年版)[J].中华糖尿病杂志,2017,9(11):667-675.
- [7] Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, et al. Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American college of endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm-2018 executive summary[J]. Endocr Pract, 2018, 24(1):91-120.

- [8] 胡蕴,马建华.医院内血糖监测现状及对策[J].中国实用内科杂志,2016,36(10):849-852.
- [9] 母义明.住院患者的一体化血糖管理方案[J].中国糖尿病杂志,2013,21(1):93-96.
- [10] 山西医科大学第一医院,山西医科大学护理学院,山西省护理学会,等.新时代护士处方权内容专家共识[J].护理研究,2018,32(1):1-5.
- [11] 公双双,吕静,王双艳,等.从国外护士处方权的发展到我国护士处方权的实施[J].护士进修杂志,2016,31(20):1848-1851.
- [12] 宋华文,韩世范,程金莲,等.应用Delphi法对糖尿病专科护士处方内容的初步探讨[J].全科护理,2012,10(10):865-867.
- [13] 中华护理学会糖尿病专业委员会.高血糖患者围手术期血糖护理工作指引[J].中华护理杂志,2017,52(7):794-798.
- [14] American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2016[J]. Diabetes Care, 2016, 39(1):1-112.
- [15] 纪立农,陈莉明,郭晓蕙,等.中国慢性疾病防治基层医生诊疗手册(糖尿病分册)2015年版[J].中国糖尿病杂志,2015,23(8):673-701.
- [16] Joslin Diabetes Center and Beth Israel Deaconess Medical Center. Guideline for management of uncontrolled glucose in

甲状腺癌合并糖尿病患者术前口服5%葡萄糖溶液的可行性研究

曾定芬 蒋艳华 蒋曼 阳静 田仁娣 范玉霞 江华 张甜 李超 周雨秋

【摘要】 目的 对甲状腺癌合并糖尿病患者术前口服葡萄糖的可行性进行探讨,旨在减少甲状腺癌合并糖尿病患者的术后并发症,提高患者舒适度。**方法** 选取2017年1月—2018年7月98例行甲状腺癌手术的糖尿病患者为试验组,采用随机分组法将试验组患者分为试验组1与试验组2,选取2016年1月—12月52例行甲状腺癌手术的糖尿病患者为对照组。试验组1术前口服温开水,试验组2术前口服5%葡萄糖溶液,对照组采取传统的禁食禁水方法。分别比较3组的血糖、血清C反应蛋白、咽喉疼痛程度、切口感染率、切口延迟愈合率等指标。**结果** 血糖方面,试验组1及试验组2术前晨口服液体2 h后血糖的比较,差异有统计学意义($P<0.001$),其余血糖的比较,差异无统计学意义;血清C反应蛋白方面,3组比较,差异有统计学意义($P<0.05$),对照组术后1 d血清C反应蛋白与试验组1、试验组2比较,差异均有统计学意义($P<0.05$);咽喉疼痛方面,对照组与试验组1、试验组2比较,差异有统计学意义($P<0.05$),试验组1与试验组2比较,差异无统计学意义($P>0.05$);3组切口延迟愈合、口渴状况比较,差异有统计学意义($P<0.05$);3组切口感染发生率比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。**结论** 术前口服5%的葡萄糖溶液不增加甲状腺癌合并糖尿病患者的术后血糖,能减轻患者的咽喉部疼痛与口渴感,能降低术后应激,减少患者切口延迟愈合的发生率。

【关键词】 甲状腺肿瘤; 糖尿病; 葡萄糖; 加速康复外科; 围手术期护理

The application of preoperative oral glucose intake in thyroid cancer patients with diabetes/ZENG Dingfen, JIANG Yanhua, JIANG Man, YANG Jing, TIAN Rendu, FAN Yuxia, JIANG Hua, ZHANG Tian, LI Chao, ZHOU Yuqiu

【Abstract】 Objective To explore the feasibility of oral glucose intake before surgery in thyroid cancer patients with diabetes for the purpose of decreasing complications and increasing comfort. **Methods** Between January 2017 and July 2018, 98 patients with thyroid cancer and diabetes were selected as the experimental group, and were further randomly divided into two subgroups: experimental group 1 and experimental group 2. Fifty-two patients diagnosed between January 2016 and December 2016 were selected as the control group. Experimental group 1 received preoperative warm water intake, experimental group 2 had preoperative oral 5% glucose intake, and the control group was traditionally abstinent from food and water before surgery. Blood glucose, C reactive protein, throat



本文作者:曾定芬

DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2019.08.005

基金项目:四川省卫生和计划生育委员会普及应用项目(18PJ219)

作者单位:610041 成都市 四川省肿瘤医院/四川省癌症防治中心/电子科技大学医学院附属肿瘤医院头颈外科二病区

通信作者:范玉霞, E-mail: 903440685@qq.com

曾定芬:女,副主任护师,护士长, E-mail: 352746190@qq.com

2019-01-03收稿

- the hospitalized adult[EB/OL]. [2019-01-24]. https://www.joslin.org/unc_gluc_in_hosp_guideline_final_5_13.pdf.
- [17] 陈莉明. 糖尿病特殊人群的血糖监测[J]. 中华糖尿病杂志, 2016, 8(12): 709-712.
- [18] 吴远, 田浩明. 中国成人住院围手术期的血糖管理[J]. 中华内科杂志, 2017, 36(3): 213-215.

- [19] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10(1): 4-67.
- [20] Canadian Diabetes Association. In-hospital management of diabetes clinical order sets[J]. Can J Diabetes, 2013, 8(12): 1-12.

(本文编辑 周 晔)